ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 декабря 2025 г. № 206

Об утверждении клинического протокола

На основании абзаца девятого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», подпункта 8.3 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить клинический протокол «Диагностика и лечение стриктур уретры у мужчин (взрослое население)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр **А.В.Ходжаев**

СОГЛАСОВАНО
Брестский областной
исполнительный комитет

Витебский областной
исполнительный комитет

Гомельский областной
исполнительный комитет

Гродненский областной
исполнительный комитет

Могилевский областной
исполнительный комитет

Минский областной
исполнительный комитет

Минский городской
исполнительный комитет

Государственный пограничный
комитет Республики Беларусь

Комитет государственной
безопасности Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Министерство обороны
Республики Беларусь

Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь

Национальная академия
наук Беларуси

Управление делами Президента
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
23.12.2025 № 206

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
«Диагностика и лечение стриктур уретры у мужчин (взрослое население)»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий клинический протокол устанавливает общие требования к объему оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях пациентам (мужчинам) со стриктурами уретры (взрослое население) (шифры по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра: N35.0 Посттравматическая стриктура уретры; N35.1 Постинфекционная стриктура уретры, не классифицированная в других рубриках; N35.8 Другая стриктура уретры; N35.9 Стриктура уретры неуточненная; N99.1 Послеоперационная стриктура уретры).

2. Для целей настоящего клинического протокола используются основные термины и определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», а также следующие термины и их определения:

стриктура уретры – комплексный патологический процесс, развивающийся вследствие повреждения эпителия уретры и приводящий к развитию фиброза спонгиозного тела с последующим сужением просвета мочеиспускательного канала, локализующийся в одном из отделов передней уретры;

уретрография – рентгенологический метод исследования уретры посредством введения рентгенконтрастного вещества в наружное отверстие мочеиспускательного канала с получением графического изображения – уретрограммы;

урофлоуметрия – клинический метод исследования уродинамики, который заключается в регистрации показателей скорости мочеиспускания в сочетании с временным интервалом, а также регистрацией графика, определяющего наличие или отсутствие обструкции;

ультразвуковое исследование (далее – УЗИ) уретры – метод исследования уретры, который проводится с введением 100 мл 0,9 % раствора NaCl в наружное отверстие уретры и предназначен для оценки выраженности спонгиофиброза в тканях, окружающих зону стриктуры.

3. Первичная медицинская помощь пациентам со стриктурами уретры оказывается в районных организациях здравоохранения, амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения по месту жительства; специализированная медицинская помощь – в районных, областных (городских), республиканских организациях здравоохранения; высокотехнологичная медицинская помощь – в областных (городских) и республиканских организациях здравоохранения.

4. Направление пациентов со стриктурой уретры для оказания медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке направления пациентов для получения медицинской помощи в организации здравоохранения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 октября 2025 г. № 137.

5. Фармакотерапия стриктуры уретры назначается в соответствии с настоящим клиническим протоколом с учетом формы, характера течения и фазы заболевания, наличия сопутствующей патологии и клинико-фармакологической характеристики лекарственных препаратов (далее – ЛП). При этом необходимо учитывать наличие индивидуальных медицинских противопоказаний, аллергологический и фармакологический анамнез.

6. Применение ЛП осуществляется по медицинским показаниям и в режиме дозирования в соответствии с общей характеристикой ЛП и инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем). Допускается включение в схему лечения ЛП по медицинским показаниям, не предусмотренным в инструкции по медицинскому применению (листке-вкладыше) и общей характеристикой ЛП (off-label). Дополнительно указываются особые условия назначения, способ применения, доза, длительность и кратность приема.

7. В каждой конкретной ситуации в интересах пациента решением врачебного консилиума объем диагностики и лечения может быть расширен с использованием иных, утвержденных Министерством здравоохранения, методов оказания медицинской помощи, не включенных в настоящий клинический протокол.

ГЛАВА 2
КЛАССИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА СТРИКТУР УРЕТРЫ

8. Основными симптомами стриктуры уретры являются обструктивные нарушения мочеиспускания:

затрудненное мочеиспускание;

слабый напор струи мочи;

ноктурия;

постмикционный симптом – чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

9. Классификация стриктур уретры:

9.1. по этиологии:

врожденные;

приобретенные;

ятрогенные: «посткатетерные», послеоперационные, постлучевые, «химические»;

посттравматические:

передней уретры – травма гениталий с разрывом белочной оболочки кавернозных тел и спонгиозного тела уретры во время полового акта, удар бульбозной уретры о лонную кость, проникающие ранения;

задней уретры – дорожно-транспортные происшествия, перелом костей таза и дистракционный разрыв костей таза;

поствоспалительные (инфекционные):

специфический и неспецифические уретриты;

Лихен склероз;

идиопатические, этиология которых остается невыясненной;

9.2. по клиническому течению заболевания:

первичные;

рецидивные;

9.3. по количеству:

одиночные;

множественные;

9.4. по локализации:

головчатого отдела уретры;

пенильного отдела уретры;

бульбозного отдела уретры;

мембранозного отдела уретры;

зоны пузырно-уретрального анастомоза (после радикальной простатэктомии);

9.5. по протяженности:

короткая ($\leq$ 2 см);

длинная ($\geq$ 2 см);

субтотальная губчатая (поражение 75–90 % губчатой уретры);

тотальная губчатая (поражение всей губчатой уретры);

тотальная (поражение всей уретры);

9.6. по степени сужения просвета мочеиспускательного канала:

легкая – просвет сужен до 50 %;

умеренная – просвет сужен до 75 %;

тяжелая – просвет сужен > 75 %;

облитерация – просвет отсутствует.

10. Диагностическими критериями стриктуры уретры являются наличие:

обструктивных симптомов нижних мочевых путей;

характерного графика мочеиспускания по данным урофлоуметрии;

сужения уретры по данным рентгенологических методов исследования (уретрограммы) или уретроцистоскопии.

11. Обязательные диагностические исследования при стриктуре уретры в амбулаторных и стационарных условиях:

11.1. клинические методы исследования:

медицинский осмотр с использованием международных шкал и опросников:

международная система суммарной оценки симптомов заболеваний предстательной железы в баллах (I-PSS) (до хирургического вмешательства) согласно приложению 1;

опросник PROM-USS согласно приложениию 2;

международный индекс эректильной дисфункции согласно приложению 3;

опросник по оценке выраженности эректильной функции (МИЭФ-5) согласно приложению 4;

11.2. лабораторные методы исследования:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

биохимический анализ крови: исследование уровня глюкозы, общего белка, общего билирубина, мочевины, креатинина, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, электролитов (калия, натрия, хлора);

простатспецифический антиген (общий) – у пациентов 45 лет и старше, при отягощенном наследственном онкоанамнезе по раку предстательной железы – у пациентов старше 40 лет;

11.3. инструментальные методы исследования:

урофлоуметрия;

уретрография;

УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи (трансабдоминально).

12. Консультации врачей-специалистов: врача-уролога, врача общей практики (врача-терапевта, врача-кардиолога и иных в зависимости от наличия сопутствующей патологии) при направлении пациентов на плановое хирургическое лечение.

13. Дополнительные диагностические исследования в амбулаторных и стационарных условиях (при наличии медицинских показаний):

13.1. лабораторные методы исследования:

бактериологический посев мочи на наличие микрофлоры и чувствительность к антибактериальным ЛП;

13.2. инструментальные методы исследования:

уретроцистоскопия;

УЗИ уретры;

компьютерная томография или магнитно-резонансная томография органов малого таза (при травматическом анамнезе стриктуры уретры);

обзорная урография;

экскреторная урография;

микционная (антеградная) цистоуретрография;

фистулография (при наличии свища);

комплексное уродинамическое исследование.

14. Повторная консультация врача-уролога, консультации врачей-специалистов по профилю сопутствующих заболеваний.

ГЛАВА 3
ЛЕЧЕНИЕ СТРИКТУР УРЕТРЫ

15. Консервативное лечение пациентов со стриктурами уретры:

поведенческая терапия (коррекция объема выпиваемой жидкости и ограничений по времени питьевого режима (уменьшение количества жидкости в вечернее и ночное время), а также режима опорожнения мочевого пузыря;

динамическое наблюдение (у пациентов с наличием медицинских противопоказаний к хирургическому лечению);

прием одного из альфа-адреноблокаторов:

тамсулозин (капсулы с модифицированным высвобождением, таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой, капсулы пролонгированного действия, таблетки пролонгированного действия) по 0,4 мг 1 раз в сутки;

силодозин (капсулы 4 мг, 8 мг) по 4 мг 1 раз в сутки) в течение длительного времени, возможно назначение ЛП на постоянной основе.

16. Хирургическое лечение пациентов со стриктурами уретры:

16.1. бужирование уретры – паллиативный метод лечения путем растяжения или увеличения диаметра просвета уретры в области сужения различными способами (бужи, катетеры, баллонные дилататоры).

Бужирование уретры, как метод лечения, применяется у пациентов с наличием медицинских противопоказаний к хирургическому вмешательству, а также в качестве поддерживающего метода после анастомотической пластики уретры.

Уретроррагия и инфекция нижних мочевых путей в стадии обострения являются медицинскими противопоказаниями к выполнению бужирования уретры;

16.2. внутренняя оптическая уретротомия (далее – ВОУ) – малоинвазивный метод лечения стриктуры уретры у мужчин, при которой под оптическим контролем выполняется рассечение слизистой уретры и рубцовой зоны спонгиозного тела на 12 часах условного циферблата.

Может применяться ВОУ с рассечением уретры «холодным ножом», а также с помощью различных видов энергии – лазерной, плазмокинетической, биполярной и иных, в зависимости от технической оснащенности организации здравоохранения.

Медицинские показания для выполнения ВОУ:

при первичных стриктурах бульбозного отдела уретры нетравматичного генеза протяженностью до 1 см;

при возникновении стриктур в дистальном или проксимальном конце анастомоза у пациентов, перенесших различные виды уретропластики;

при рецидивных коротких стриктурах (до 1 см), а также у коморбидных пациентов и пациентов, отказывающихся от выполнения реконструктивного хирургического вмешательства (возможно выполнение ВОУ более 2 раз).

Не рекомендуется выполнять повторную ВОУ при рецидивных стриктурах уретры после 2 неуспешных попыток ранее выполненной ВОУ;

16.3. анастомотическая уретропластика – реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство, при котором выполняется полное иссечение суженного, рубцово-трансформированного участка уретры вместе с патологически измененным спонгиозным телом, дополняемое спатуляцией краев уретры, с последующим выполнением анастомоза между здоровыми концами уретры.

Данный вид хирургического вмешательства выполняют при стриктурах протяженностью от 1,5 до 4 см и облитерациях уретры.

Не рекомендуется выполнять анастомотическую уретропластику при стриктурах пенильного отдела уретры любой протяженности в связи с потенциальным риском формирования укорочения и деформации полового члена.

При выполнении анастомотической уретропластики необходимы: адекватная мобилизация уретры, иссечение рубцовой деформации в пределах здоровых тканей, наложение анастомоза без натяжения краев уретры, отсутствие деформации и укорочения полового члена;

16.4. аугментационная уретропластика – реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство, при котором выполняется увеличение просвета пораженного отдела мочеиспускательного канала с использованием трансплантата или лоскута. В качестве первичного трансплантата предпочтительно использовать слизистую ротовой полости.

Аугментационная уретропластика применяется при стриктурах пенильного отдела уретры и бульбозного отдела уретры длиной более 4 см с использованием дорзального типа фиксации трансплантата;

16.5. заместительная многоэтапная уретропластика – реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство, при котором выполняется формирование нового сегмента уретры взамен пораженного, обычно требующее двух или более хирургических пособий.

Заместительная многоэтапная уретропластика показана при протяженных стриктурах уретры с тяжелой степенью спонгиофиброза, дефицитом местных тканей или Лихен склерозе.

Финальный этап заместительной многоэтапной уретропластики проводят не ранее трех месяцев после предыдущего этапа, соответствующих периоду «уретрального отдыха».

После первого этапа может иметь место контрактура (сморщивание) новой уретральной площадки в зоне трансплантата, что требует повторного хирургического вмешательства для коррекции уретральной площадки перед финальным этапом, заключающимся в тубуляризации уретры;

16.6. перинеостома (промежностная уретростома) – тип хирургического вмешательства, при котором на кожу промежности выводится проксимальный отрезок бульбозной уретры после формирования трапециевидного лоскута без коррекции пораженной части мочеиспускательного канала.

Перинеостома (промежностная уретростома) показана при протяженных и субтотальных стриктурах уретры пациентам с отягощенной сопутствующей патологией, как более простая альтернатива иным методам уретропластики;

16.7. цистостомия – установка пункционной или троакарной цистостомы у пациентов с отсутствующим самостоятельным мочеиспусканием. Данный вид лечения используется как временный перед планируемым хирургическим вмешательством, так и постоянный, при наличии медицинских противопоказаний или отказе пациента от предложенного лечения.

17. Медицинские показания и выбор метода хирургического вмешательства определяется лечащим врачом, в сложных случаях – врачебным консилиумом.

18. Медикаментозная терапия при хирургических вмешательствах у пациентов со стриктурой уретры включает назначение антибиотиков с учетом результата бактериологического посева мочи на наличие микрофлоры и чувствительность к антибактериальным ЛП:

18.1. при отсутствии инфекции мочевыводящих путей (клинически значимой бактериурии) при эндоскопических и открытых хирургических вмешательствах на уретре и мочевом пузыре проводится периоперационная антибиотикопрофилактика: однократно за 30–60 минут до начала хирургического вмешательства назначают внутривенно цефазолин 2,0 г (при массе тела пациента более 120 кг – 3,0 г), разовую дозу разводят в 10 мл 0,9 % раствора натрия хлорида и вводят внутривенно медленно в течение 3–5 минут;

18.2. при наличии клинически значимой бактериурии выбор антибактериального ЛП для антибиотикопрофилактики перед хирургическим вмешательством основывается на результатах бактериологического посева мочи на наличие микрофлоры и чувствительность к антибактериальным ЛП;

18.3. при аллергии на бета-лактамные антибиотики используются следующие комбинации ЛП (в зависимости от клинической ситуации):

клиндамицин внутривенно 900 мг + гентамицин 5 мг/кг внутривенно;

клиндамицин внутривенно 900 мг + ципрофлоксацин 400 мг внутривенно;

метронидазол внутривенно 500 мг + гентамицин 5 мг/кг внутривенно;

метронидазол внутривенно 500 мг + ципрофлоксацин 400 мг внутривенно.

В послеоперационном периоде продолжается введение антибактериальных ЛП, которые использовались для периоперационной антибиотикопрофилактики не более 24 часов;

18.4. медикаментозная терапия, направленная на скорейшее восстановление сексуальной активности, проводится у пациентов, мотивированных на ее восстановление, и предусматривает:

назначение ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа в раннем послеоперационном периоде – тадалафил (таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг, 20 мг) по 5 мг 1 раз в сутки с первого дня после хирургического вмешательства в течение 1–3 месяцев;

коррекцию выявленного перед хирургическим вмешательством андрогенного дефицита с применением ЛП тестостерона: тестостерон (раствор для внутримышечного введения 250 мг/мл) внутримышечно по 250 мг 1 раз в сутки под контролем уровня тестостерона крови;

18.5. при выполнении реконструктивных хирургических вмешательств на уретре с целью снижения вероятности рецидива стриктуры, редукции графта, улучшения трофики графта и области анастомоза применяются регенеративные технологии (тромбоцитарный гель, плазма, обогащенная тромбоцитами и иное).

19. Медицинская профилактика венозных тромбоэмболических осложнений (далее – ВТЭО) включает последовательные этапы:

оценка степени риска ВТЭО и риска геморрагических осложнений;

выбор способа медицинской профилактики ВТЭО: немедикаментозный или комбинированный (немедикаментозный + медикаментозный);

определение длительности медицинской профилактики.

20. К немедикаментозным методам медицинской профилактики ВТЭО относятся:

максимальная и возможно более ранняя активизация пациента после хирургического вмешательства, включая методы пассивной нагрузки (вертикализация, механотерапия, кинезиотерапия и иные);

обеспечение максимально возможной активности мышц нижних конечностей пациентов, находящихся на длительном постельном режиме;

механические способы медицинской профилактики (компрессионный трикотаж, перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей);

активные и пассивные нагрузки на верхние конечности, улучшающие циркуляцию крови в целом, стимулирующие антитромботическую активность эндотелия;

адекватная гидратация.

21. Степень риска ВТЭО у госпитализированных пациентов оценивают по шкале Каприни согласно приложению 5.

22. У пациентов с низким риском ВТЭО при ограничении подвижности применяются эластическая компрессия и другие методы немедикаментозной медицинской профилактики.

23. У пациентов с умеренным риском ВТЭО, а также у пациентов с высоким риском ВТЭО и очень высоким риском ВТЭО к немедикаментозным методам добавляется один из антикоагулянтов.

Режим дозирования и способ применения антикоагулянтов для медицинской профилактики ВТЭО у пациентов со стриктурой уретры в зависимости от риска по шкале Каприни установлен согласно приложению 6.

24. У пациентов с чрезвычайно высоким риском ВТЭО используется сочетание медикаментозной медицинской профилактики, переменной пневматической компрессии и эластической компрессии. Производится индивидуальный подбор дозы нефракционированного гепарина и низкомолекулярных гепаринов. Целевым диапазоном анти-Ха-активности (на фоне применения низкомолекулярных гепаринов) считается 0,2–0,5 МЕ/мл при исследовании через 3–4 часа после очередной инъекции и 0,1–0,2 МЕ/мл при исследовании через 12 часов после очередной инъекции.

25. Продолжительность медицинской профилактики ВТЭО:

у пациентов с умеренным риском – не менее 10 дней или до полного восстановления двигательной активности пациента;

при высоком, очень высоком и чрезвычайно высоком риске – не менее 4 недель.

26. Критерии оценки эффективности лечения пациентов со стриктурой уретры:

«эффект не достигнут» – контрольные параметры (количество баллов по шкале IPSS согласно приложению 1 и/или PROM-USS согласно приложению 2, остаточная моча, показатели урофлоуметрии) улучшены менее чем на 50 % от исходного уровня;

«улучшение» – контрольные параметры улучшены на 50–75 % от исходного уровня;

«значительное улучшение» – контрольные параметры улучшены более чем на 75 % от исходного уровня;

«ухудшение» – изменение в сторону снижения контрольных параметров более чем на 25 % относительно исходного уровня или возобновление симптомов спустя 6 месяцев после улучшения.

27. Исходами лечения стриктур уретры являются:

излечение – наличие самостоятельного мочеиспускания удовлетворительного качества по данным отсутствия симптомов или показателя максимальной скорости мочеиспускания по показателям урофлоуметрии не менее 12 мл/с и отсутствием остаточной мочи по данным УЗИ мочевого пузыря;

рецидив – повторное сужение мочеиспускательного канала, приводящее к возникновению и нарастанию симптомов нижних мочевых путей после проведенного хирургического вмешательства.

ГЛАВА 4
МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ СО СТРИКТУРОЙ УРЕТРЫ

28. Медицинское наблюдение пациентов со стриктурой уретры в амбулаторных условиях осуществляет врач-уролог, врач-хирург, врач общей практики амбулаторно-поликлинической организации по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы).

29. Периодичность медицинского наблюдения врача-уролога, выполнение УЗИ почек и мочевого пузыря, урофлоуметрии в амбулаторных условиях зависит от симптомов нижних мочевых путей.

30. Медицинское наблюдение пациентов со стриктурой уретры в послеоперационном периоде:

максимально раннее удаление уретрального катетера после хирургического вмешательства: через 1–3 суток после ВОУ и через 10–21 суток после уретропластики;

уретрография для оценки заживления в зоне уретропластики через 7–28 суток в зависимости от метода хирургического вмешательства. При наличии установленного катетера после хирургического вмешательства выполняется «перикатетерная» уретрография (введение рентгенконтрастного вещества в уретру рядом с катетером);

урофлоуметрия для контроля эффективности хирургического вмешательства через 3 месяца.

В случае отсутствия восстановления адекватного мочеиспускания сохраняется действующая цистостома, а в случае ее отсутствия показано выполнение цистостомии.

Длительность медицинского наблюдения за пациентами, перенесшими различные виды хирургического вмешательства на уретре, не менее 1 года.

Приложение 1
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
стриктур уретры у мужчин
(взрослое население)»

Международная система суммарной оценки симптомов заболеваний предстательной железы в баллах (I-PSS) (до хирургического вмешательства)*

№ п/п	Шкала I-PSS	Никогда	Реже чем 1 раз из пяти	Реже чем в половине случаев	Примерно в половине случаев	Чаще, чем в половине случаев	Почти всегда
	Перечень вопросов	0	1	2	3	4	5
1	Как часто в течение последнего месяца у Вас было ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания?						
2	Как часто в течение последнего месяца у Вас была потребность мочиться чаще, чем через 2 часа после последнего мочеиспускания?						
3	Как часто в течение последнего месяца у Вас имелось прерывистое мочеиспускание?						
4	Как часто в течение последнего месяца Вам было трудно временно воздержаться от мочеиспускания?						
5	Как часто в течение последнего месяца у Вас была слабая струя мочи?						
6	Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось натуживаться, чтобы начать мочеиспускание?						
		Нет	1 раз	2 раза	3 раза	4 раза	5 или более раз
7	Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось вставать ночью с постели, чтобы помочиться?						
	Суммарный балл по I-PSS:						

* Интерпретация результатов оценки симптомов заболеваний предстательной железы согласно количеству баллов:

от 0 до 7 – незначительные нарушения;

от 8 до 19 – умеренные нарушения;

от 20 до 35 – тяжелые симптомы болезни.

Приложение 2
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
стриктур уретры у мужчин
(взрослое население)»

Опросник PROM-USS

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется):
_____
Дата заполнения: _____
Контактный телефон: _____
Отметьте ответ, наиболее точно описывающий Ваши симптомы за последние 4 недели*.

1. Испытываете ли Вы затруднения перед началом мочеиспускания?
Никогда □-0
Периодически □-1
Иногда □-2
В большинстве случаев □-3
Всегда □-4

2. Как бы Вы описали напор струи при мочеиспускании?
Нормальный □-0
Периодически снижен □-1
Иногда снижен □-2
Снижен в большинстве случаев □-3
Снижен всегда □-4

3. Вынуждены ли Вы натуживаться для продолжения мочеиспускания?
Никогда □-0
Периодически □-1
Иногда □-2
В большинстве случаев □-3
Всегда □-4

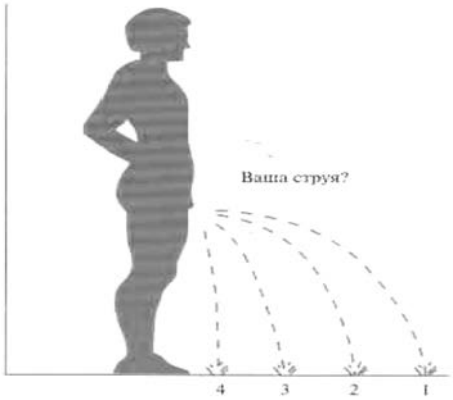
4. Бывает ли у Вас прерывание струи более одного раза за мочеиспускание?
Никогда □-0
Периодически □-1
Иногда □-2
В большинстве случаев □-3
Всегда □-4

5. Как часто Вы испытываете чувство неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания?
Никогда □-0
Периодически □-1
Иногда □-2
В большинстве случаев □-3
Всегда □-4

6. Как часто после того, как Вы уже закончили мочеиспускание и оделись, Вы ощущаете непроизвольное подтекание мочи/намокание белья?
Никогда □-0
Периодически □-1
Иногда □-2
В большинстве случаев □-3
Всегда □-4

7. Оцените, насколько сильно симптомы, связанные с мочеиспусканием, влияют на Вашу жизнь:
Не влияют совсем □
Незначительно □
Немного □
Сильно □

8. Отметьте цифру, соответствующую напору Вашей струи мочи за последний месяц (на рисунке):



9. Удовлетворены ли Вы результатом хирургического вмешательства?**

Да, очень доволен □
Да, удовлетворен □
Нет, не удовлетворен □
Нет, совсем не удовлетворен □

10. Если Вы не удовлетворены, то это потому, что...**

Качество мочеиспускания не улучшилось □
Качество мочеиспускания улучшилось, но появились новые проблемы □
Качество мочеиспускания не улучшилось и появились новые проблемы □

Пожалуйста, отметьте галочкой один квадратик в каждом из разделов, приведенных ниже. Укажите такие ответы, которые наилучшим образом отражают состояние Вашего здоровья на сегодняшний день.

11. Подвижность:

Я не испытываю никаких трудностей при ходьбе □-1
Я испытываю некоторые трудности при ходьбе □-2
Я прикован к постели □-3

12. Уход за собой:

Я не испытываю трудностей при уходе за собой □-1
Я испытываю некоторые трудности с мытьем или одеванием □-2
Я не в состоянии сам мыться или одеваться □-3

13. Привычная повседневная деятельность

(например, работа, учеба, работа по дому, участие в делах семьи, досуг):

Моя привычная повседневная деятельность дается мне без труда □-1
Моя повседневная деятельность для меня несколько затруднительна □-2
Я не в состоянии заниматься своей повседневной деятельностью □-3

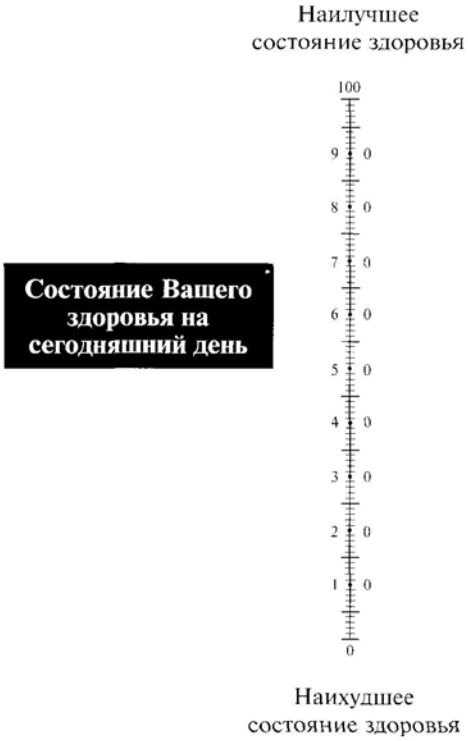
14. Боль/дискомфорт:

Я не испытываю боли или дискомфорта □-1
Я испытываю умеренную боль или дискомфорт □-2
Я испытываю сильную боль или дискомфорт □-3

15. Тревога/депрессия:

Я не испытываю тревоги или депрессии □-1
Я испытываю умеренную тревогу или депрессию □-2
Я испытываю сильную тревогу или депрессию □-3

Для того, чтобы помочь опрашиваемым высказать свое мнение о том, насколько плохо или хорошо их состояние здоровья, мы изобразили шкалу, похожую на термометр, на которой наилучшее состояние здоровья, которое Вы можете себе представить, обозначено цифрой 100, а наихудшее состояние, которое Вы можете себе представить, обозначено цифрой 0. Мы бы хотели, чтобы на этой шкале Вы указали, насколько хорошим или плохим, по Вашему мнению, является состояние Вашего здоровья на сегодняшний день. Для этого Вы должны провести линию от отметки 0 внизу до той точки на шкале, которая соответствует состоянию Вашего здоровья на сегодняшний день.



* Если у Вас установлен уретральный катетер или надлобковый катетер (катетер в нижнем отделе живота), пожалуйста, начинайте отвечать с 11 вопроса.

** 9 и 10 вопросы предназначены для пациентов, перенесших хирургическое вмешательство по поводу стриктуры уретры.

Приложение 3
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
стриктур уретры у мужчин
(взрослое население)»

Международный индекс эректильной дисфункции

Дата заполнения:
Контактный телефон:
Пожалуйста, выберите и отметьте <u>только один вариант</u> при ответе на каждый вопрос:

1. В течение последних 4 недель как часто Вы могли достигать эрекции при сексуальной активности?
[0] Не было сексуальной активности.
[1] Почти никогда или никогда.
[2] Несколько раз (гораздо меньше, чем в половине случаев).
[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине случаев).
[5] Почти всегда или всегда.

2. В течение последних 4 недель, когда Вы достигали эрекции при сексуальной стимуляции, как часто Ваша эрекция была достаточной для введения полового члена во влагалище партнерши?
[0] Не было сексуальной активности.
[1] Почти никогда или никогда.
[2] Несколько раз (гораздо меньше, чем в половине случаев).
[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине случаев).
[5] Почти всегда или всегда.

3. В течение последних 4 недель, когда Вы предпринимали попытки проведения полового акта, как часто Вы были в состоянии ввести половой член (войти) во влагалище партнерши?
[0] Не было попыток проведения полового акта.
[1] Почти никогда или никогда.
[2] Некоторое время (гораздо меньше, чем в половине случаев).
[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине случаев).
[5] Почти всегда или всегда.

4. В течение последних 4 недель, когда Вы предпринимали попытки проведения полового акта, как часто Вы были в состоянии сохранить эрекцию после введения полового члена во влагалище партнерши?
[0] Не было попыток проведения полового акта.
[1] Почти никогда или никогда.
[2] Некоторое время (гораздо меньше, чем в половине случаев).
[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине случаев).
[5] Почти всегда или всегда.

5. В течение последних 4 недель, когда Вы предпринимали попытки проведения полового акта, как трудно Вам было сохранить эрекцию до конца полового акта?
[0] Не было попыток проведения полового акта.
[1] Исключительно трудно.
[2] Очень трудно.
[3] Трудно.
[4] Не очень трудно.
[5] Совсем не трудно.

6. В течение последних 4 недель сколько раз Вы предпринимали попытку проведения полового акта?
[0] Не было попыток.
[1] Одну-две попытки.
[2] Три-четыре попытки.
[3] Пять-шесть попыток.
[4] Семь-десять попыток.
[5] Одиннадцать или более.

7. В течение последних 4 недель, когда Вы предпринимали попытку проведения полового акта, как часто Вы были удовлетворены?
[0] Не было попыток проведения полового акта.
[1] Почти никогда или никогда.
[2] Несколько раз (гораздо меньше, чем половину).
[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине).
[5] Почти всегда или всегда.

8. В течение последних 4 недель насколько Вы были удовлетворены половым актом?
[0] Не было попыток проведения полового акта.
[1] Не получил удовлетворения.
[2] Не очень большое удовлетворение.
[3] Достаточное удовлетворение.
[4] Большое удовлетворение.
[5] Очень сильное удовлетворение.

9. В течение последних 4 недель при проведении сексуальной стимуляции или половом акте как часто у Вас происходила эякуляция?
[0] Не было попыток проведения сексуальной стимуляции или полового акта.
[1] Почти никогда или никогда.
[2] Несколько раз (гораздо меньше, чем в половине случаев).

[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине).
[5] Почти всегда или всегда.

10. В течение последних 4 недель при проведении сексуальной стимуляции или половом акте как часто Вы испытывали оргазм (с или без эякуляции)?

[0] Не было попыток проведения сексуальной стимуляции или полового акта.
[1] Почти никогда или никогда.
[2] Несколько раз (гораздо меньше, чем в половине случаев).
[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине).
[5] Почти всегда или всегда.

11. В течение последних 4 недель как часто Вы испытывали сексуальное желание?

[1] Почти никогда или никогда.
[2] Несколько раз (гораздо меньше, чем в половине случаев).
[3] Иногда (около половины).
[4] В большинстве случаев (гораздо больше, чем в половине).
[5] Почти всегда или всегда.

12. В течение последних 4 недель какова Ваша оценка уровня Вашего сексуального желания?

[1] Очень низкий или совсем отсутствует.
[2] Низкая.
[3] Средняя.
[4] Высокая.
[5] Очень высокая.

13. В течение последних 4 недель насколько Вы в целом удовлетворены сексуальной жизнью?

[1] Очень неудовлетворен.
[2] Неудовлетворен.
[3] В равной степени удовлетворен и неудовлетворен.
[4] Достаточно удовлетворен.
[5] Полностью удовлетворен.

14. В течение последних 4 недель насколько Вы удовлетворены сексуальными отношениями с партнершей?

[1] Очень неудовлетворен.
[2] Неудовлетворен.
[3] В равной степени удовлетворен и неудовлетворен.
[4] Достаточно удовлетворен.
[5] Полностью удовлетворен.

15. В течение последних 4 недель как Вы оцениваете свою уверенность в возможности достигать и сохранять эрекцию?

[1] Очень низко.
[2] Низко.
[3] Средне.
[4] Высоко.
[5] Очень высоко.

Приложение 4
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
стриктур уретры у мужчин
(взрослое население)»

Опросник по оценке выраженности эректильной функции (МИЭФ-5)

№ п/п	Перечень вопросов	Чрезвычайно трудно; почти никогда или никогда	Очень трудно; редко (реже, чем в половине случаев)	Трудно; иногда (примерно в половине случаев)	Не очень трудно; часто (более, чем в половине случаев)	Нетрудно; почти всегда или всегда
1	Как часто у Вас возникала эрекция при сексуальной активности за последнее время?	1	2	3	4	5
2	Как часто у Вас за последнее время возникающая эрекция была достаточна для введения полового члена (для начала полового акта)?	1	2	3	4	5
3	Как часто у Вас при попытке полового акта получалось осуществить введение полового члена (начать половой акт)?	1	2	3	4	5
4	Как часто Вам за последнее время удавалось сохранить эрекцию после начала полового акта?	1	2	3	4	5
5	Насколько трудно Вам было сохранить эрекцию в течение и до конца полового акта?	1	2	3	4	5
	Общая сумма баллов степени выраженности эректильной функции:					
	Оценка симптомов общей суммы баллов:					
	21–25 баллов	норма (отсутствие эректильной дисфункции)				
	16–20 баллов	легкая эректильная дисфункция				
	11–15 баллов	умеренная эректильная дисфункция				
	5–10 баллов	значительная эректильная дисфункция				

Приложение 5
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
стриктур уретры у мужчин
(взрослое население)»

Шкала Каприни*

Факторы риска развития ВТЭО	Баллы
Возраст 41 год–60 лет Отек нижних конечностей Варикозные вены Избыток массы тела > 25 кг/м^2 Малое хирургическое вмешательство Сепсис	1

Заболевания легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема легких, иные) Острый инфаркт миокарда Хроническая сердечная недостаточность Длительный постельный режим Воспалительные заболевания толстой кишки в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона) Обширное хирургическое вмешательство давностью до 1 месяца в анамнезе	
Возраст 61 год – 74 года Артроскопическая хирургия Злокачественное новообразование Лапароскопическое вмешательство (длительностью более 45 мин) Постельный режим более 72 часов Иммобилизация конечности (давностью до 1 месяца) Катетеризация центральных вен Обширное хирургическое вмешательство длительностью более 45 мин	2
Возраст 75 лет и старше Личный анамнез ВТЭО Семейный анамнез ВТЭО Мутация типа Лейден (FVL) Мутация протромбина (FII G20210A) Гипергомоцистеинемия Гепарин-индуцированная тромбоцитопения Повышенный уровень антител к кардиолипину Волчаночный антикоагулянт Другая врожденная или приобретенная тромбофилия	3
Инсульт (давностью до 1 месяца) Множественная травма (давностью до 1 месяца) Эндопротезирование крупных суставов Перелом костей бедра и голени (давностью до 1 месяца) Травма спинного мозга и (или) паралич (давностью до 1 месяца)	5

* Результаты оценки теста по шкале Каприни представляются в виде суммы полученных баллов:
0–2 балла: низкий риск ВТЭО;
3–4 балла: умеренный риск ВТЭО;
5–8 баллов: высокий риск ВТЭО;
9–10 баллов: очень высокий риск ВТЭО;
11 и более баллов: чрезвычайно высокий риск ВТЭО.

Приложение 6
к клиническому протоколу
«Диагностика и лечение
стриктур уретры у мужчин
(взрослое население)»

Режим дозирования и способ применения антикоагулянтов для медицинской профилактики ВТЭО у пациентов со стриктурой уретры в зависимости от риска по шкале Каприни

№ п/п	Международное непатентованное наименование ЛП	Способ применения, дозы	
		Умеренный риск ВТЭО по шкале Каприни	Высокий и очень высокий риск ВТЭО по шкале Каприни
1	Нефракционный гепарин, раствор для внутривенного и подкожного введения 5000 МЕ/мл во флаконах	Подкожно 5000 МЕ за 2–4 часа до хирургического вмешательства, затем через 6–8 часов после хирургического вмешательства и далее 5000 МЕ 2–3 раза в сутки	Подкожно 5000 МЕ за 4–6 часов до хирургического вмешательства, 5000 МЕ через 6–8 часов после хирургического вмешательства, далее – по 5000 МЕ 3 раза в сутки
2	Далтепарин натрия, раствор для инъекций 2500 МЕ/0,2 мл в шприцах 0,2 мл; раствор для инъекций 5000 МЕ/0,2 мл в шприцах 0,2 мл;	Подкожно 2500 МЕ за 2 часа до хирургического вмешательства, в последующие дни 2500 МЕ 1 раз в сутки	Подкожно 5000 МЕ вечером накануне хирургического вмешательства, затем 5000 МЕ 1 раз в сутки или подкожно 2500 МЕ за 2 часа

	раствор для инъекций 10000 МЕ/1 мл в ампулах 1 мл		до хирургического вмешательства, затем 2500 МЕ через 12 часов (но не ранее, чем через 4 часа после окончания хирургического вмешательства), затем со следующего дня 5000 МЕ 1 раз в сутки
3	Надропарин кальция, раствор для подкожного введения 9500 МЕ анти-Ха/мл в шприцах 0,3 мл (2850 МЕ анти-Ха), 0,4 мл (3800 МЕ анти-Ха), 0,6 мл (5700 МЕ анти-Ха) 0,8 мл (7600 МЕ анти-Ха)	Подкожно 2850 МЕ (0,3 мл) за 2–4 часа до хирургического вмешательства, в последующие дни по 0,3 мл 1 раз в сутки	У пациентов с массой тела менее 50 кг: доза ЛП, вводимого за 12 часов до и через 12 часов после хирургического вмешательства, далее – 1 раз в сутки до третьего дня после хирургического вмешательства составляет 1900 МЕ (0,2 мл); доза ЛП, вводимого 1 раз в сутки, начиная с четвертого дня после хирургического вмешательства составляет 2850 МЕ (0,3 мл) У пациентов с массой тела 51–70 кг: доза ЛП, вводимого за 12 часов до и через 12 часов после хирургического вмешательства, далее – 1 раз в сутки до третьего дня после хирургического вмешательства составляет 2850 МЕ (0,3 мл); доза ЛП, вводимого 1 раз в сутки, начиная с четвертого дня после хирургического вмешательства составляет 3800 МЕ (0,4 мл) У пациентов с массой тела более 70 кг: доза ЛП, вводимого за 12 часов до и через 12 часов после хирургического вмешательства, далее 1 раз в сутки до третьего дня после хирургического вмешательства составляет 3800 МЕ (0,4 мл); доза ЛП, вводимого 1 раз в сутки, начиная с четвертого дня после хирургического вмешательства составляет 5700 МЕ (0,6 мл)
4	Эноксапарин натрия, раствор для инъекций 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ/0,8мл	Подкожно 20 мг за 2 часа до хирургического вмешательства, в последующие дни 20 мг 1 раз в сутки	Подкожно 40 мг за 12 часов до хирургического вмешательства, затем 40 мг 1 раз в сутки после хирургического вмешательства
5	Фондапаринукс натрия, раствор для внутривенного и подкожного введения 2,5 мг/0,5 мл в шприцах	Подкожно 2,5 мг не ранее, чем через 6 часов после хирургического вмешательства, в последующие дни 2,5 мг 1 раз в сутки	Подкожно 2,5 мг не ранее, чем через 6 часов после хирургического вмешательства, в последующие дни – 2,5 мг 1 раз в сутки